

Capítulo 1: Arritmias y Emergencias Cardiovasculares

Manual de Estudio EUNACOM — Basado en Perfil 2026 y Guías Clínicas MINSAL / GES

CAPÍTULO 1

EUNACOM Medicina Interna • República de Chile

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

1.1 Manejo de Urgencias en Arritmias --
1.2 Paro Cardiorespiratorio --
1.4 Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos --
1.5 Fibrilación Auricular --
1.12 Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV) --
1.13 TV y Canalopatías --
Tablas Comparativas del Capítulo
Comparación de Arritmias Supraventriculares
Clasificación de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)
Referencias y Bibliografía
Referencias Bibliográficas del Capítulo
TEMA 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Específico • **Tx:** Inicial • **Seg:** Derivar

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Inestabilidad hemodinámica (hipotensión, choque, dolor isquémico, edema pulmonar agudo o alteración de conciencia) requiere cardioversión eléctrica sincronizada inmediata en taquiarritmias.
- En bradiarritmias sintomáticas o inestables, el tratamiento farmacológico inicial es Atropina 0.5 - 1 mg EV bolo, preparando marcapaso transcutáneo.
- Taquicardia de complejo QRS angosto ($<0.12s$) estable: 1° Maniobras vagales (Valsalva modificada), 2° Adenosina 6 mg EV bolo rápido.
- Taquicardia de complejo QRS ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con antecedentes cardiovasculares debe manejarse como Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Mujer de 60 años con antecedente de estenosis mitral severa e hipertensión arterial, ingresa a urgencias por disnea de reposo y palpitaciones de inicio brusco hace 2 horas. Al examen físico: paciente soporosa, pálida y sudorosa; PA 82/40 mmHg, FC 145x' irregular, MP(+) con crépitos difusos en ambos campos pulmonares y soplo diastólico IV/VI en ápex. ECG confirma Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida."

Piensa en: Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida y descompensación hemodinámica aguda (Shock cardiogénico + Edema agudo pulmonar).

Conducta: Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con 120-200 Joules previa sedación rápida si la conciencia lo permite.

Definición y Concepto Fundamental

El manejo de urgencia en arritmias comprende el conjunto de medidas diagnósticas y terapéuticas inmediatas orientadas a estabilizar al paciente que cursa con un trastorno del ritmo cardíaco asociado a riesgo vital inminente o deterioro hemodinámico severo. La premisa fundamental en la medicina de urgencia no es el diagnóstico electrocardiográfico exacto inicial, sino la determinación del estado de perfusión tisular y la presencia de inestabilidad hemodinámica.

Fisiopatología de la Inestabilidad Hemodinámica

Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias severas alteran el gasto cardíaco. En las taquiarritmias severas (frecuencias $> 150x'$), el tiempo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo disminuye drásticamente, lo que reduce el volumen sistólico, colapsa el gasto cardíaco y disminuye la perfusión de las arterias coronarias. En las bradiarritmias severas (frecuencias $< 40x'$), la frecuencia extremadamente baja es insuficiente para mantener el gasto cardíaco mínimo requerido por los órganos nobles.

Criterios Clínicos de Inestabilidad (Los 4 Signos Cardinales)

Ante cualquier arritmia en urgencias, debe buscarse activamente la presencia de al menos uno de los siguientes 4 criterios de inestabilidad:

- **Signos de Choque / Hipotensión:** Presión arterial sistólica < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg, frialdad distal o llenado capilar lento.
- **Alteración Aguda del Estado Mental:** Somnolencia, confusión o síncope secundario a hipoperfusión cerebral.
- **Isquemia Miocárdica Activa:** Dolor torácico opresivo de características anginosas o cambios isquémicos en el ECG.
- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** Congestión pulmonar franca (crépitos bibasales difusos, ortopnea, edema pulmonar agudo).

EUNACOM TIP

En el examen EUNACOM, si un paciente con arritmia tiene hipotensión o edema pulmonar, la respuesta correcta SIEMPRE es cardioversión eléctrica. No intente fármacos primero.

DATO CLAVE

Sincronizar el cardioversor con la onda R es vital para evitar descargar sobre la onda T y precipitar una Fibrilación Ventricular (fenómeno R sobre T).

MINSAL GES

El protocolo SAMU / Red de Urgencia exige monitor con parches de desfibrilación instalados antes del traslado de todo paciente arritmico inestable.

Perlas Clínicas EUNACOM

- En taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se realiza DESFIBRILACIÓN NO SINCRONIZADA inmediata.
- La dosis de adenosina debe administrarse mediante técnica de dos llaves (bolo rápido seguido inmediatamente de 20 ml de SF).
- En bradiarritmias por sobredosis de betabloqueadores el antídoto específico es el Glucagón EV.

Fármacos Clave en Manejo de Urgencias en Arritmias

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Adenosina	TPSV regular de complejo angosto estable	6 mg EV bolo rápido + 20 ml SF	Contraindicada en asma severo. Causa rubor y pausa asistólica.
Amiodarona	TV monomórfica estable / FA descompensada	150 mg EV en 10 min, infusión 1 mg/min	Hipotensión arterial, bradicardia. Monitorizar QT.
Atropina	Bradiarritmia sintomática / BAV nodal	0.5 - 1 mg EV bolo (máx 3 mg)	Ineficaz en BAV infranodal (Mobitz II / BAV 3°).

Pregunta 11 EUNACOM

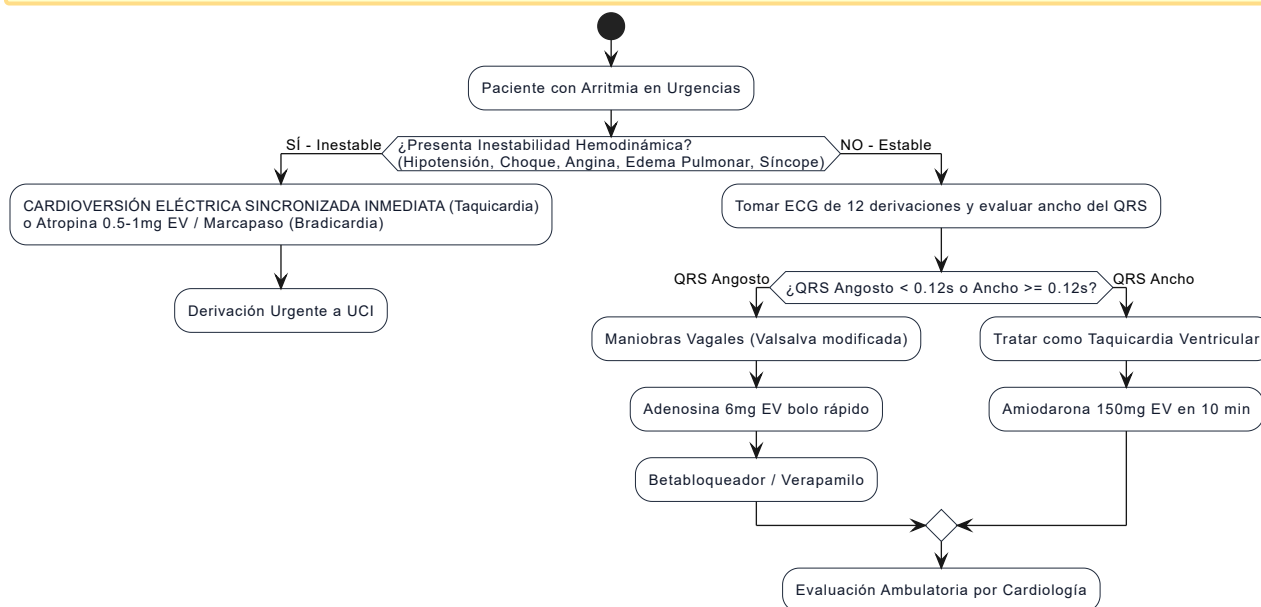
Mujer de 60 años, con estenosis mitral severa, inicia bruscamente disnea y palpitaciones. Al examen FC:140x', PA:85/35, MP(+), con crépitos intensos y difusos, RI2T con soplo diastólico IV/VI en ápex. La conducta inicial más adecuada es:

- A) Administrar amiodarona endovenosa en bolo
 B) Entregar oxígeno a FiO2 elevadas y soporte ventilatorio con BiPAP
 C) Reponer fluidos con suero fisiológico
 D) Cardioversión eléctrica inmediata
 E) Administrar furosemda endovenosa asociada a drogas vasoactivas

Respuesta Correcta D: Paciente hemodinámicamente inestable (PA 85/35 mmHg) por taquiarritmia con edema pulmonar agudo. La indicación absoluta de primera línea es la cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y MANEJO AGUDO DE ARRITMIAS

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.



TEMA 1.2

Paro Cardiorespiratorio

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Dx: Específico • **Tx:** Completo • **Seg:** Derivar

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Diagnóstico de Paro: Paciente inconsciente + no responde + no respira normalmente + ausencia de pulso carotídeo comprobada en < 10 segundos.
- Ritmos Desfibrilables: Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVsp).
- Ritmos NO Desfibrilables: Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). Requieren RCP inmediata y Adrenalina precoz.
- Calidad de las Compresiones: Frecuencia 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión torácica completa, minimizar interrupciones (<10s).

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Hombre de 58 años, hipertenso y fumador, se desploma súbitamente en urgencias. Al evaluarlo, no responde y no se palpa pulso carotídeo en 5 segundos. El monitor muestra actividad eléctrica caótica e irregular sin complejos QRS reconocibles."

Piensa en: Paro Cardiorespiratorio en Fibrilación Ventricular (Ritmo desfibrilable).

Conducta: Iniciar compresiones torácicas inmediatamente -> Aplicar descarga de 200 Joules bifásico e inmediatamente reiniciar RCP por 2 minutos.

Definición y Etiología del Paro Cardiorespiratorio (PCR)

El paro cardiorespiratorio es la cesación brusca e inesperada de la actividad mecánica cardíaca y de la respiración espontánea. En adultos, más del 80% de los casos de PCR son de causa cardíaca primaria, siendo la cardiopatía coronaria agudizada la etiología más frecuente.

Fisiopatología de los Ritmos de Paro

Los ritmos de PCR se dividen en Desfibrilables (FV / TVsp) y NO Desfibrilables (Asistolia / AESP). La asistolia representa la ausencia total de actividad eléctrica. La AESP presenta despolarización eléctrica sin contracción mecánica efectiva.

EUNACOM TIP

En asistolia NUNCA desfibrilar. Confirmar el trazado en al menos 2 derivaciones y buscar causas 5H y 5T.

DATO CLAVE

La capnografía cuantitativa (ETCO2) monitoriza la calidad de las compresiones. Un valor < 10 mmHg indica RCP ineficaz.

Perlas Clínicas EUNACOM

- Frecuencia de ventilación tras intubación endotraqueal: 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto) sin pausar compresiones.
- La causa reversible más común de AESP en pacientes traumatizados o hipotensos es la hipovolemia severa.

Fármacos Clave en Paro Cardiorespiratorio

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Adrenalina	PCR (Todos los ritmos)	1 mg EV bolo c/3-5 min (1:10.000)	En asistolia/AESP dar de inmediato. En FV/TVsp dar tras 2° descarga.
Amiodarona	FV / TVsp refractaria a descargas	1° dosis 300 mg EV, 2° dosis 150 mg EV	Administrar tras 3° descarga si persiste ritmo desfibrilable.

Pregunta 19 EUNACOM

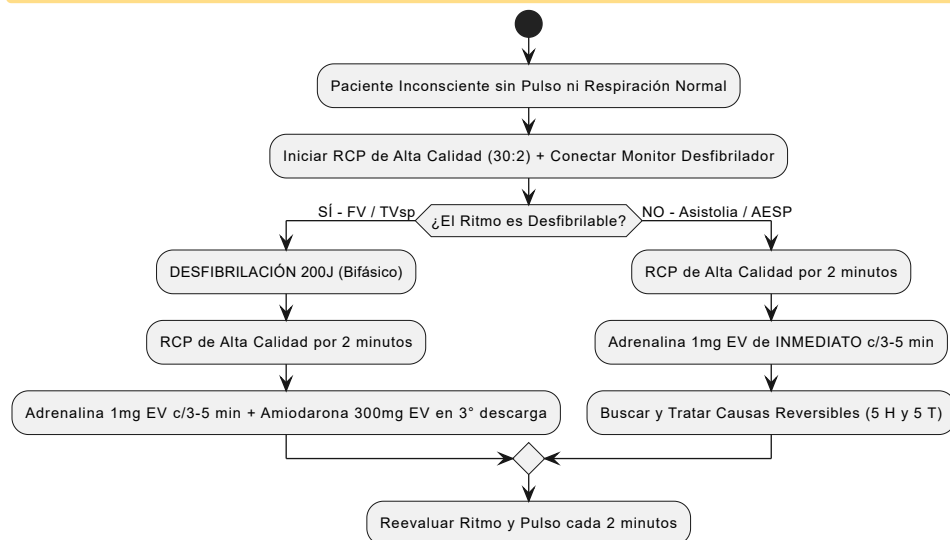
Paciente de 58 años sufre paro cardíaco presenciado. Se inicia RCP y el monitor demuestra asistolia. La medida farmacológica más adecuada e inmediata es:

- A) Administrar atropina 1 mg EV
 B) Administrar amiodarona 300 mg EV
 C) Administrar adrenalina 1 mg EV
 D) Realizar choque eléctrico de 200J
 E) Administrar bicarbonato de sodio 1 mEq/kg

Respuesta Correcta C: En ritmos NO desfibrilables (asistolia y AESP), la adrenalina 1 mg EV debe administrarse lo antes posible junto con la RCP de alta calidad.

ALGORITMO GENERAL DE SOPORTE VITAL AVANZADO (ACLS)

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.



TEMA 1.4

Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.002

Dx: Específico • **Tx:** Inicial • **Seg:** Derivar
 Aspectos Esenciales (High Yield)

- BAV de 1° Grado: PR > 0.20 segundos constante. Todas las ondas P conducen. Generalmente benigno.
- BAV de 2° Grado Mobitz I (Wenckebach): Prolongación progresiva del PR hasta que una onda P no conduce. Sitio: Nódulo AV.
- BAV de 2° Grado Mobitz II: PR constante con falla intermitente de conducción P. Sitio: Infranodal -> Requiere Marcapaso Definitivo.
- BAV de 3° Grado (Completo): Disociación AV completa -> Marcapaso Definitivo Garantizado (GES N° 25).

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Hombre de 74 años con antecedentes de HTA y DM2, consulta por mareos profundos y dos síncope. FC 34x' regular, PA 145/80. ECG: Ondas P a 75x' y complejos QRS anchos a 34x', sin relación temporal entre P y QRS."

Piensa en: Bloqueo Auriculoventricular Completo (BAV de 3° Grado) con ritmo de escape idioventricular.

Conducta: Hospitalizar en unidad monitorizada, marcapaso transitorio si inestable e implante de Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

Fisiopatología de los Trastornos de Conducción AV

Los bloqueos auriculoventriculares ocurren por una alteración en el sistema de conducción cardíaco que retarda o interrumpe la transmisión del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. El sitio anatómico del bloqueo determina el pronóstico y respuesta a Atropina.

GES CHILE

GES N° 25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años que requieren marcapaso definitivo están garantizados por ley.

EUNACOM TIP

Paciente mayor con síncope y QRS ancho a FC 30-35x' -> Pensar en BAV 3° y marcar Marcapaso Definitivo.

Perlas Clínicas EUNACOM

- El infarto agudo de miocardio de pared inferior suele cursar con BAV de 2° Mobitz I o BAV 3° nodal transitorio que responde a Atropina.
- La hiperkalemia es la causa metabólica reversible más frecuente de bradicardia con ensanchamiento progresivo del QRS.

Fármacos Clave en Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Atropina	Bradicardia sinusal / BAV Nodal 0.5 - 1 mg EV bolo c/3-5 min (máx 3 mg)	Ineficaz en bloqueos infranodales (Mobitz II / BAV 3°).	

Pregunta 7 EUNACOM

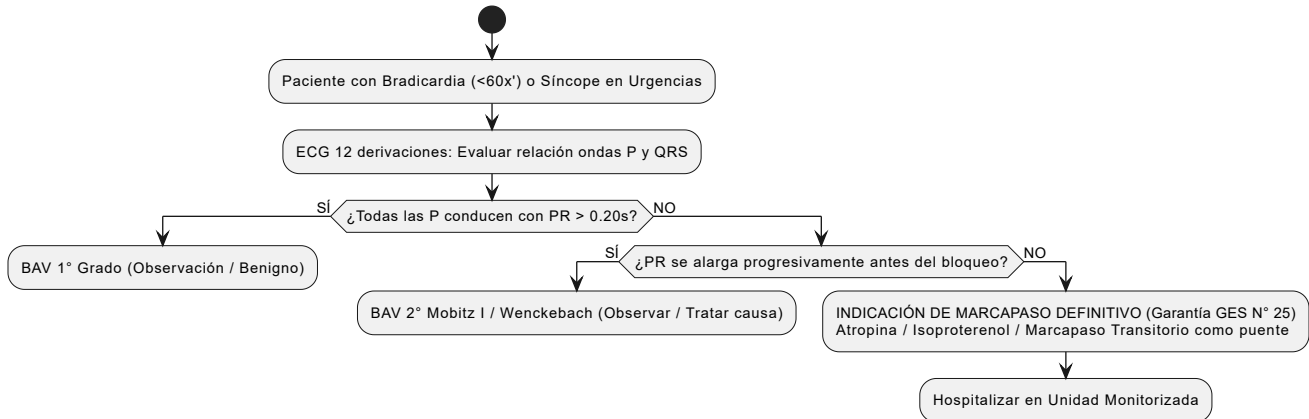
Paciente de 72 años con antecedentes de HTA y diabetes, ingresa por episodio sincopal sin traumatismo. Al ECG se evidencia ritmo sinusal con FC 35x', ondas P independientes de los complejos QRS, los cuales son anchos (QRS 0.14s). El diagnóstico y manejo de elección es:

- A) BAV 2° Mobitz I - Observación clínica
- B) BAV 1° Grado - Atropina EV a permanencia
- C) Enfermedad del nodo sinusal - Amiodarona EV
- D) BAV 3° Grado - Instalación de marcapaso definitivo
- E) Bloqueo completo de rama izquierda - Coronariografía urgente

Respuesta Correcta D: Disociación AV en paciente sincopal es BAV 3° Grado. Tratamiento definitivo: Marcapaso Definitivo (GES N° 25).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO DE BLOQUEOS AV

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.



TEMA 1.5

Fibrilación Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Dx: Específico • **Tx:** Inicial • **Seg:** Completo

Aspectos Esenciales (High Yield)

- La arritmia cardíaca sostenida más frecuente. Su principal causa etiológica es la Hipertensión Arterial (HTA).
- Hallazgos ECG: Ausencia de ondas P (ondas 'f' de fibrilación) e intervalos R-R irregularmente irregulares.
- Complicación Cardinal: Embolia sistémica (ACV Isquémico) por formación de trombos en la orejuela izquierda.
- Estratificación Antitrombótica: Escala CHA₂DS₂-VASc indica necesidad de Anticoagulación Oral (ACO) a permanencia.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Mujer de 68 años, hipertensa, consulta por palpitaciones de 2 semanas asociadas a fatiga. PA 138/84, FC 118x' irregular. Pulso deficitario. Sin congestión pulmonar. ECG confirma Fibrilación Auricular."

Piensa en: Fibrilación Auricular no valvular hemodinámicamente estable.

Conducta: Calcular CHA₂DS₂-VASc (3 puntos: HTA + Edad 65-74 + Sexo Femenino) -> Iniciar Anticoagulación Oral a permanencia + Betabloqueador.

Fisiopatología y Remodelado Auricular

La Fibrilación Auricular se origina por múltiples micro-reentradas auriculares impulsadas por focos ectópicos automáticos localizados en las venas pulmonares. La HTA causa dilatación auricular y remodelado miocárdico.

En la red pública de Chile (FONASA/APS), el Acenocumarol es el anticoagulante de primera línea entregado en el PSCV.

EUNACOM TIP

FA Valvular (Estenosis Mitral o Prótesis Mecánica) REQUIERE anticoagulación con Warfarina/Acenocumarol. Los DOACs están contraindicados.

Perlas Clínicas EUNACOM

- El uso de Aspirina para prevención de stroke en FA no valvular está descatalogado por falta de eficacia frente al riesgo hemorrágico.
- La FA silente o asintomática tiene el mismo riesgo de provocar un ACV embólico que la FA sintomática.

Fármacos Clave en Fibrilación Auricular

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Bisoprolol / Carvedilol	Control de FC en FA (1° Línea)	Bisoprolol 2.5 - 10 mg/día VO	Evitar en asma severo descompensado y bradicardia.
Acenocumarol / Warfarina	Anticoagulación en FA (Estándar APS Chile)	Ajustada por INR (Meta 2.0 - 3.0)	Requiere controles periódicos de coagulación.

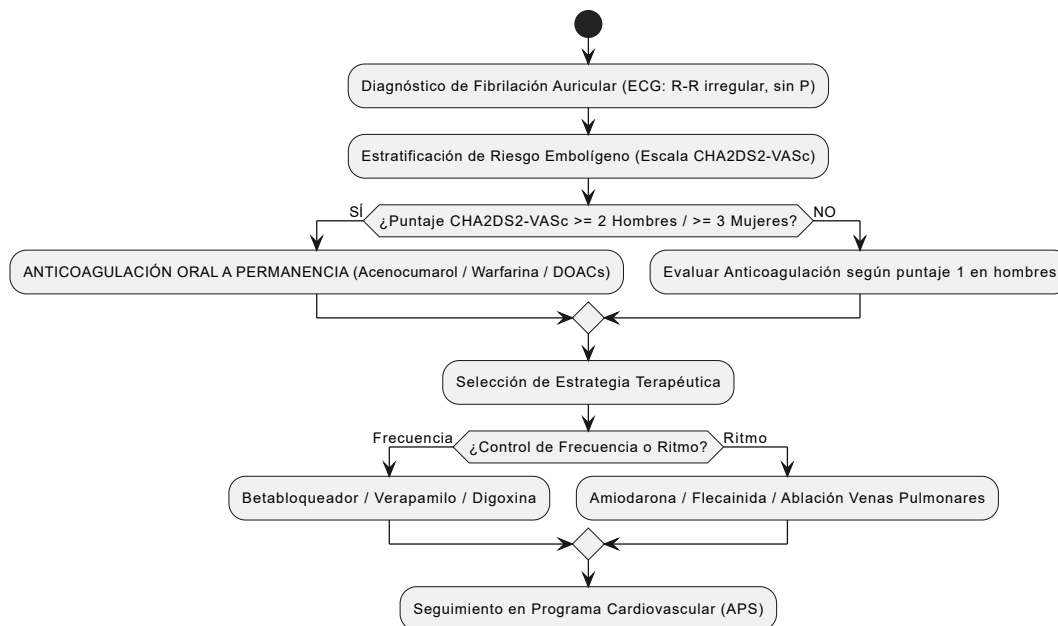
Pregunta 6 EUNACOM

Mujer de 65 años, hipertensa en tratamiento con enalapril, consulta por palpitaciones e intolerancia al esfuerzo de 3 semanas de evolución. ECG demuestra fibrilación auricular con FC 110x'. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 44 mm y FE 55%. Su puntaje CHA₂DS₂-VASc es de 3 puntos. La conducta antitrombótica más adecuada es:

- A) Aspirina 100 mg/día
- B) Clopidogrel 75 mg/día
- C) Anticoagulación oral a permanencia
- D) Doble terapia antiagregante con aspirina y clopidogrel
- E) No requiere tratamiento antitrombótico

Respuesta Correcta C: En FA no valvular con CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 en hombres o ≥ 3 en mujeres, existe indicación absoluta de Anticoagulación Oral a permanencia.

ESTRATEGIA GLOBAL AF-CARE DE MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR



TEMA 1.12

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

PERFIL EUNACOM 1.01.1.024

Dx: Específico • **Tx:** Inicial • **Seg:** Completo

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Taquicardia regular de complejo QRS angosto ($<0.12s$) más frecuente en pacientes jóvenes sin cardiopatía.
- Mecanismo principal: Reentrada Nodal AV (60%) y Reentrada AV por Vía Accesorio (WPW) (30%).
- Tratamiento Agudo: 1° Maniobras Vagales (Valsalva modificada). 2° Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Mujer de 28 años sin antecedentes consulta por palpitaciones intensas de inicio brusco. FC 185x', PA 115/75. ECG: Taquicardia regular QRS angosto sin P visibles."

Piensa en: Taquicardia Paroxística Supraventricular por Reentrada Nodal.

Conducta: Maniobras Vagales (Valsalva modificada). Si no cede -> Adenosina 6 mg EV en bolo rápido.

Fisiopatología de la Reentrada Nodal AV

La Taquicardia por Reentrada Nodal Auriculoventricular ocurre por una doble vía de conducción en el nódulo AV (vía rápida y vía lenta). Un extrasístole desencadena la reentrada.

EUNACOM TIP

Paciente joven con TPSV estable -> La PRIMERA MEDIDA son las Maniobras Vagales.

Perlas Clínicas EUNACOM

- En WPW con Fibrilación Auricular está CONTRAINDICADO usar Verapamilo, Adenosina o Digoxina.

Fármacos Clave en Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Adenosina	1° opción farmacológica en TPSV	6 mg EV bolo rápido -> 12 mg EV	Contraindicada en asma severo.

Pregunta 8 EUNACOM

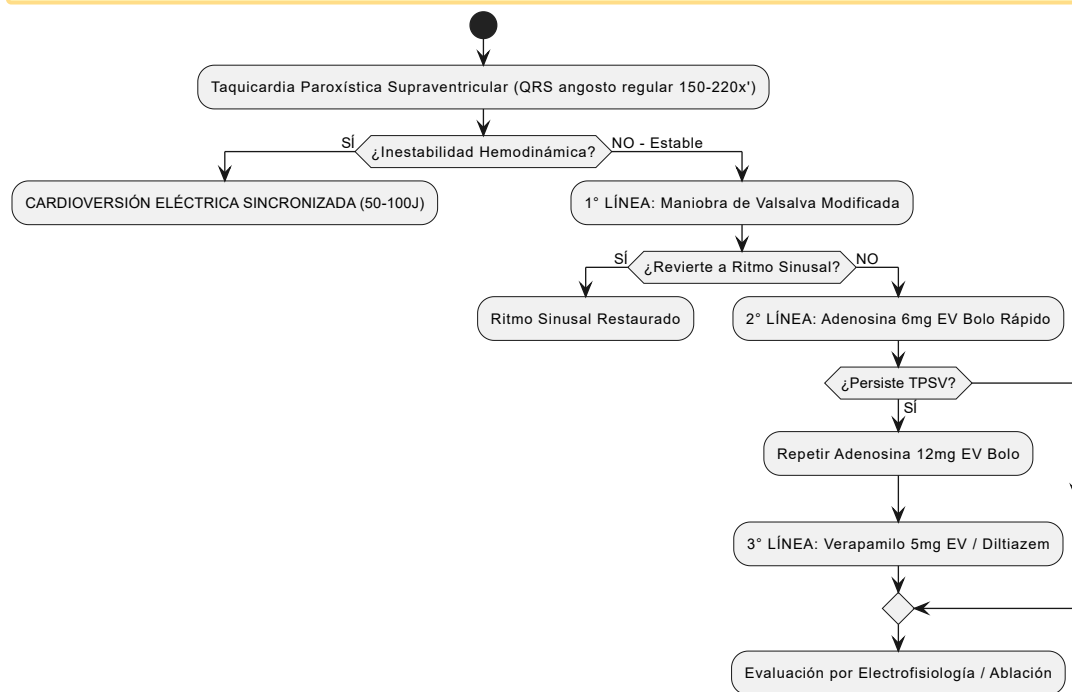
Mujer de 30 años con palpitaciones muy intensas de inicio y término brusco. PA:110/70, FC:180x'. ECG: Taquicardia regular QRS angosto. Primera medida a seguir:

- A) Administrar adenosina endovenosa
- B) Administrar amiodarona endovenosa
- C) Realizar cardioversión eléctrica
- D) Realizar maniobras vagales
- E) Administrar propafenona oral

Respuesta Correcta D: En TPSV regular a QRS angosto estable, la primera medida no invasiva son las maniobras vagales.

ALGORITMO DE MANEJO DE TPSV EN URGENCIAS

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.



TEMA 1.13

TV y Canalopatías

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Sospecha • **Tx:** Inicial • **Seg:** Derivar

Aspectos Esenciales (High Yield)

- Taquicardia de QRS Ancho ($\geq 0.12s$) en adulto con cardiopatía debe considerarse Taquicardia Ventricular hasta demostrar lo contrario.
- TV Monomórfica Estable: Amiodarona 150 mg EV en 10 min o Procainamida.
- Canalopatías: Síndrome de QT Largo (Torsades de Pointes) y Síndrome de Brugada.

Caso Clínico Tipo EUNACOM

"Hombre de 65 años con infarto antiguo presenta palpitaciones y mareos. PA 105/65, FC 170x'. ECG: Taquicardia regular QRS ancho (0.16s) con disociación AV."

Piensa en: Taquicardia Ventricular Monomórfica Sostenida.

Conducta: Amiodarona 150 mg EV en 10 min si estable. Cardioversión si inestable.

Diagnóstico Diferencial de QRS Ancho

Toda taquicardia de complejos anchos en un paciente adulto con infarto previo debe ser manejada como Taquicardia Ventricular. Dar Verapamilo causa colapso hemodinámico letal.

Ante la duda en taquicardia de QRS ancho en adulto -> SIEMPRE tratar como Taquicardia Ventricular.

Perlas Clínicas EUNACOM

- Los latidos de captura y fusión en el ECG confirman el diagnóstico de Taquicardia Ventricular.

Fármacos Clave en TV y Canalopatías

Fármaco	Indicación	Dosis	Precauciones
Amiodarona	TV Monomórfica Estable	150 mg EV en 10 min -> Infusión 1 mg/min	Monitorear presión arterial.

Pregunta 14 EUNACOM

Paciente de 68 años con antecedente de infarto previo ingresa por palpitaciones. PA: 110/70, FC: 160x'. ECG: Taquicardia regular QRS ancho con capturas. Conducta más adecuada:

A) Administrar amiodarona 150 mg EV en 10 minutos
B) Administrar verapamilo 5 mg EV
C) Realizar maniobras vagales
D) Administrar adenosina 6 mg EV bolo
E) Alta con propranolol oral

Respuesta Correcta A: Taquicardia de QRS ancho con capturas en paciente con infarto previo es TV. Al estar estable, el tratamiento inicial es Amiodarona EV.

ALGORITMO DE TAQUICARDIA DE QRS ANCHO

This syntax is deprecated, you must add <<#ffe4e6>> at the end of the line, after the ';'.

TABLAS COMPARATIVAS DE CAPÍTULO

Tabla Comparativa: Arritmias Supraventriculares				
Característica	Fibrilación Auricular	Flutter Auricular	TPSV (Reentrada Nodal)	Extrasístoles Auriculares
Frecuencia Auricular	350 - 600 x'	250 - 350 x' (típico 300)	150 - 220 x'	Variable (prematura)
Ritmo Ventricular	Irregularmente Irregular	Regular (2:1 a 150x') o Irregular	Estrictamente Regular	Regular con pausa prematura
Onda P en ECG	Ausente (Ondas 'f')	Ondas 'F' en serrucho	Ocultas o P' retrógradas	P' prematura distinta
Respuesta a Adenosina	Enlentecimiento de la respuesta ventricular	Desenmascara ondas en serrucho	REVIERTE a ritmo sinusal	Sin efecto relevante
Tratamiento Definitivo	Ablación de venas pulmonares / ACO	Ablación del Istmo Cavotricuspidal	Ablación de vía lenta nodal	Generalmente no requiere

Tabla Comparativa: Clasificación de Antiarrítmicos (Vaughan-Williams)				
Clase	Mecanismo de Acción Principal	Fármacos Ejemplos	Indicaciones Clave	Riesgos / Precauciones
Clase Ia	Bloqueo moderado de canales de Na ⁺	Procainamida, Quinidina	TV, WPW, FA	Prolongación QT, hipotensión
Clase Ib	Bloqueo leve de canales de Na ⁺	Lidocaína, Fenitoína	Arritmias ventriculares post-IAM	Ineficaz en supraventriculares
Clase Ic	Bloqueo potente de canales de Na ⁺	Flecainida, Propafenona	Cardioversión FA en corazón sano	CONTRAINDICADO en isquemia/IC
Clase II	Betabloqueadores (β-1 antag)	Bisoprolol, Carvedilol, Atenolol	Control FC en FA, TPSV, Prevención IAM	Broncoespasmo, bradicardia
Clase III	Bloqueo de canales de K ⁺	Amiodarona, Sotalol, Dronedarona	FA, Flutter, TV, Prevención muerte súbita	Toxicidad tiroidea/pulmonar
Clase IV	Bloqueo de canales de Ca ²⁺ no-DHP	Verapamilo, Diltiazem	Control FC en FA, TPSV	CONTRAINDICADO en IC/FE (FE < 40%)

Referencias y Bibliografía del Capítulo

1. Perfil EUNACOM 2026 Versión 3. Ministerio de Salud de Chile / ASOFAMECH.
2. Guía de Práctica Clínica GES N°5: Infarto Agudo del Miocardio con SDST. MINSAL Chile, 2018.
3. Guía de Práctica Clínica GES N°25: Trastornos de conducción en mayores de 15 años. MINSAL Chile.
4. Consenso Chileno de Fibrilación Auricular. SOCHICAR / Revista Chilena de Cardiología, 2020-2024.